

Czym jest *psychoza*?

To stan, w którym kontakt z rzeczywistością jest osłabiony — nie „szaleństwo”, lecz objaw, który może wystąpić w różnych zaburzeniach. Wyzdrowienie jest możliwe.

CZAS: 10 min czytania · Pierwsza wizyta · psychoedukacja

ŹRÓDŁO: Zubin & Spring (1977); Anthony (1993); McGrath i in. (2008); Jääskeläinen i in. (2013)

JAK UŻYWAĆ

Psychoza to **stan, w którym osoba traci kontakt z rzeczywistością** — doświadcza urojeń, halucynacji lub dezorganizacji myślenia. To *nie diagnoza*, a **objaw**, który może pojawić się w schizofrenii, epizodzie maniakałnym, ciężkiej depresji, po substancjach lub przy chorobach mózgu. Rozpowszechnienie schizofrenii: ok. **1%** populacji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Model **podatność—stres** (Zubin & Spring, 1977) tłumaczy, skąd psychoza się bierze: *biologiczna podatność* (geny, neurobiologia) plus *stresor* (życiowy, substancja, deprywacja snu) przekraczają indywidualny próg. Czynniki ochronne *podnoszą* ten próg. Recovery (Anthony, 1993): wyzdrowienie nie oznacza „braku objawów” — oznacza **pełnię życia mimo objawów**.

01 📋 Trzy główne objawy psychozy

UROJENIA

falszywe przekonania

Mocne, niepoddające się dowodom przekonania, np. że ktoś *śledzi*, że telewizja *nadaje sygnały*, że *posiada się nadprzyrodzoną misję*. Najczęściej: prześladowcze, odnoszące (wszystko mnie dotyczy), wpływu.

HALUCYNACJE

doznania bez bodźca

Słyszenie głosów, których inni nie słyszą (*najczęstsze*). Widzenie, czucie zapachu, doznania ciała bez źródła zewnętrznego. Głosy mogą komentować, krytykować, rozkazywać.

DEZORGANIZACJA

myślenia i zachowań

Trudność w utrzymaniu wątku, „skoki” myśli, mowa trudna do śledzenia. Zachowania nieadekwatne do sytuacji. *Mózg „nie układa” informacji w spójną całość*.

02 ✖ Mit kontra fakt

MIT

„Psychoza to *szaleństwo*. Osoba z psychozą jest niebezpieczna. Schizofrenia oznacza rozdwojenie osobowości. Nie da się **z tego** wyjść.”

FAKT

Psychoza to **objaw medyczny** (jak gorączka). Ryzyko agresji nie jest większe niż w populacji ogólnej. Schizofrenia to *nie* rozdwojenie. **25-50%** osób osiąga pełną remisję (Jääskeläinen, 2013).

03 🧠 Model podatność—stres w jednym obrazie



04 Wyzdrowienie ma trzy wymiary

Anthony (1993) — twórca koncepcji zdrowienia (ang. *recovery model*) — pokazał, że „wyzdrowienie” w psychozie to nie tylko zniknięcie objawów. To **trzy odrębne wymiary**, które można rozwijać równolegle.

KLINICZNE

redukcja objawów

Mniej głosów, słabsze urojenia, jaśniejsze myślenie. **25-50%** pełnej remisji klinicznej (Jääskeläinen, 2013).
Farmakoterapia + CBTp to filary.

FUNKCJONALNE

powrót do życia

Praca, nauka, relacje, samodzielność. **50-70%** osób osiąga znaczącą poprawę funkcjonalną (WHO ISoS, 2001).
Kluczowe: wspomagane zatrudnienie, struktura dnia.

OSOBISTE

sens, nadzieja, tożsamość

„Jestem *kimś więcej* niż moja choroba”. Nadzieja, sens życia, tożsamość poza diagnozą. Tego nie mierzy się skalą — mierzy się tym, jak **żyje się**.

05 Twoje pytania i refleksje

Zatrzymaj się przy tej karcie. Co rezonuje? Co budzi opór? Jakie pytania chciałbyś/-abyś zadać terapeutce na następnej sesji?

CO MNIE ZASKOCZYŁO

— jedna lub dwie rzeczy z tej karty

PYTANIA NA NASTĘPNĄ SESJĘ

— do terapeuty lub psychiatry

Klucz: psychoza to *objaw*, nie wyrok. Model podatność—stres tłumaczy, dlaczego pojawiła się u Ciebie w tym momencie życia — i pokazuje, że **można na nią wpłynąć**: leki obniżają biologiczny próg pobudzenia, sen i ograniczenie substancji redukują stresor, terapia i wsparcie społeczne podnoszą zasoby. W meta-analizie Jääskeläinen i in. (2013) **13,5%** osób osiągnęło pełną remisję, a **do 50%** — znaczącą poprawę. Wyzdrowienie nie jest gwarancją — ale jest realną możliwością, którą warto traktować jako cel.